随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、检查

对水敏感　小耳朵

①**B超（首选）：液性暗区，常为多个** VS 转移性肝癌-牛眼征:边缘明显强化

②CT：囊性低密度灶、增强后明显**边缘强化**（脓肿壁为肉芽组织），常为多个

内有丰富血管,脓肿液(水)在CT上不强化

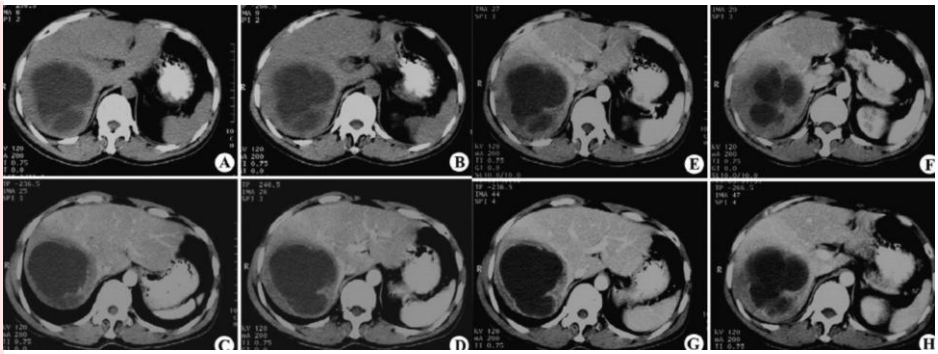
③**肝穿刺（金标准）**

感染扩散

《诊断学》：禁止肝穿刺：肝包虫病、肝血管瘤等　血管很多很脆,穿刺易引起大量出血

细菌性肝脓肿,细菌可以入血,但是不做血培养而要做肝穿刺,因为肝脓肿是在肝脏内一个封闭的脓腔,细菌是间歇性入血的,不是持续入血,因此血培养阳性率不高,确诊一定靠肝穿刺在脓液里找到细菌

VS感染性心内膜炎赘生物长到瓣膜上,持续暴露在血循环中,因此有持续性的菌血症,血培养是感染性心内膜炎的首选和金标准,结合银标准超声心动图诊断,不可能做穿刺。



四、治疗

①**三代头孢+甲硝唑**：首选；且是小而多的细菌性肝脓肿最佳方法（小耳朵）

②单发较大脓肿（3-5cm）还需**穿刺/置管引流**

抗生素→抗生素+穿刺置管引流→抗生素+手术的切开引流　胆源性　破裂

↓肝部分切除

脓肿>5cm、分隔多　大多　慢性

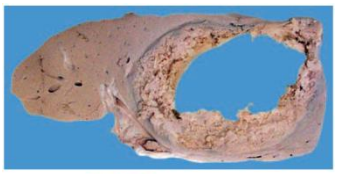


图 18-19　阿米巴肝脓肿

肝右叶被一巨大的脓肿所占据，脓肿壁呈破絮状外观。

五、鉴别

细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
化脓性炎	变质性炎
起病急、寒战高热	毒血症状不重　起病缓、少有高热
血 WBC↑、以中性粒细胞为主	血 WBC 可↑、以嗜酸性粒细胞 ttsx 为主
黄白色脓液、可有臭味，脓液找到细菌确诊	果酱样脓液　非厌氧菌　棕褐色脓液、无臭味，脓液找到滋养体确诊
脓肿常较小、多发	脓肿常较大、单发（右叶多见）　右叶大

专题串联·肝解剖

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



肝外胆管×

①**G**lisson 鞘：肝**内**胆管、肝动脉、**门静脉**（注意：没有肝静脉）　记忆:肝十二指肠韧带中,把肝外胆管变成肝内胆管

②**C**ouinaud 分段依据：**肝静脉**、**门静脉**（格格没有的、我察贵人有、我有 2 个静脉）

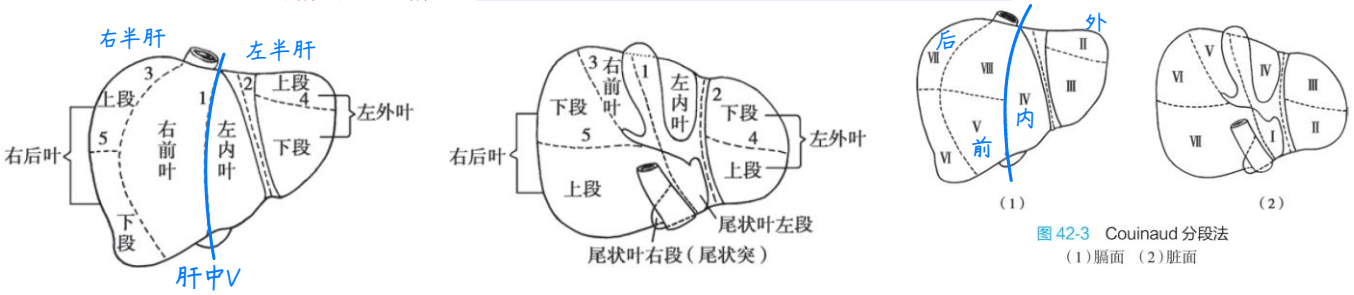


图 42-3　Couinaud 分段法

(1)膈面　(2)脏面

真题解析·细菌性肝脓肿

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

